Diskussion 672

Datum: 1931-05-13
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 7
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Harald Åkerberg (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag har i denna fråga väckt en motion. Den rör emellertid endast en detalj, nämligen själva utbildningstiden. Utskottet har avstyrkt denna motion, och det finns inte heller någon reservation till förmån för densamma. Jag tänker inte lägga ned något arbete på att försöka övertala kammaren att fränträda utskottets ståndpunkt, utan jag får väl vara nöjd med det resultat, vartill utskottet har kommit. Jag skall i stället be att få säga några ord om utskottsförslaget eller rättare sagt om den reservation, som flertalet av mina partivänner i utskottet har anslutit sig till.

Herr Pauli sade, att regeringspropositionen var i alltför hög grad uppburen av romantik, men jag tycker, att den reservation, som herr Pauli själv har anslutit sig till, i stället är buren i alltför hög grad av realism, av läkarerealism, av nyttighetspolitik. Man skall ju inte säga något ont om läkarna — jag högaktar deras skrå — men man har ingen anledning att knäfalla inför dem, och man kan inte heller komma ifrån, att inom detta skrå finnas tendenser, som inte äro så roliga. Det finns där monopoltendenser, och jag har den uppfattningen, att vad som framträtt i samband med denna fråga och som funnit uttryck 1 reservationen just är sådana monopoltendenser. Vi känna ju till den politik, som läkarna drivit i fråga om **sjuksköterskorna³**. Där är deras ståndpunkt, att en **sjuksköterska³**, en distriktssköterska t. ex., inte får ha någon självständig ställning, **hon²** skall i allt sortera under läkaren och vara hans springflicka. Om **hon²** träder utanför den ramen och lägger om ett bandage på ett finger, eller någonting sådant, så har **hon²** gjort sig skyldig till brott emot den heliga ande. Här drives samma politik i fråga om sjukgymnasterna. De få inte heller ha någon som helst självständig ställning. Man skall till och med driva det därhän, att deras utbildning skall kontrolleras och helt stå under läkarnas uppsikt. De få icke alls vid utbildningen beblandas med gymnastiklärare och friskgymnaster. :

Det står här i reservationen på sid. 46, att det är nödvändigt att göra klart för sig, att det här gäller behandling av sjuka människor, och det är ju alldeles riktigt. Men det finnes åtskilliga fall, som stå på gränsen och där en sjukgymnast har en insats att göra oberoende av läkarens ordination.

Men för övrigt tror jag ej det ligger något enhälligt läkarekrav ens bakom reservanternas ståndpunkt. De läkare, som verkligen satt sig in i frågan, åtminstone många av dem, äro motståndare till en skilsmässa mellan dessa båda vid institutet nu företrädda linjer. Men däremot har det för dem, som låst fast sig vid den här ståndpunkten, så småningom blivit en prestigefråga. Det har blivit en stridsställning på området, som ej kan betecknas såsom lycklig. Jag kan berätta ett exempel till belysande av detta påstående. Det gjordes från gymnastiska centralinstitutet en framställning till serafimerlasarettet om, att

vissa experiment, en viss utbildning skulle få förläggas dit. Det rörde anatomi. Framställningen blev avslagen med den motiveringen, att man ej hade material tillgängligt på sjukhuset för dessa övningar. Men samtidigt befanns det, att ett privat företag, som existerar på det här området i konkurrens med gymnastiska centralinstitutet, för sina övningar av motsvarande slag kunde få material på serafimerlasarettet. För övrigt talar man — särskilt professor Patrik Haglund, vars ande svävar över reservationen — ofta i det här fallet med två tungor. I en broschyr, författad av honom och som utdelats till riksdagsmännen, får man veta, att de svenska gymnasterna äro ena klåpare. De sägas fördärva vårt renommé i utlandet. Men i en officiell berättelse, som prof. Haglund avgivit, framhåller han, att den svenska sjukgymnastiken kommit till verkligt storartade resultat.

Herr Pauli sade, att utskottet hade modifierat propositionens linje och modifierat den i riktning mot den ståndpunkt, som reservanterna intaga. Men det förefaller också, som om reservanterna skulle ha modifierat sig i den andra riktningen. Herr Pauli sade i sitt anförande, att sjukgymnasterna kunna ju gå till G. C. I. och taga lektioner där. Och naturligtvis, när de genomgått sin kurs vid vederbörande sjukhus, skall det beredas dem tillfälle att komplettera vid institutet. Jag kan ej förstå, att detta å andra sidan ej är ett erkännande från reservanternas sida av, att deras linje har gått för långt åt det andra hållet. Och varför ej lika gärna då låta utbildningen på en gång vara gemensam”?

Jag tyckte, att herr Björck sade, att reservationen hade renhet och klarhet i sina linjer. För min del måste jag finna, att den tvärtom är ganska dimmig. Det heter där, att det skall ej vara någon speciell kurs; någon skola skall ej inrättas vid vederbörande sjukhus för sjukgymnastiken. Men hur skall det hela då inrättas? Jo, det skall vara oorganiserat! Jag kan ej förstå annat, än att det i så fall kommer att leda därhän, att den sjukgymnastiska utbildningen kommer att övertagas av de privata anstalterna, och att reservanternas linje innebär, att staten tar sin hand från hela denna utbildning.

Ej heller kan jag få in i min hjärna, hur det skall kunna bli billigare genom att dela upp utbildningen på två anstalter. Herr Pauli tyckes tro, att det ej skall behövas någon särskild personal för en sådan utbildning, om den förlägges till ett sjukhus, men klart är, att det måste vara en särskild personal, som är inställd på denna utbildning, och denna personal kan ej vara bara läkare, inte ens till övervägande grad läkare, ty de begripa i allmänhet inte saken. Nej det är klart, att det behöves ny personal och kanske större personal för det hela, ifall man

skall dela upp utbildningen på två anstalter i stället för att ha den inom samma anstalt.

Och detsamma är förhållandet med de lokala utrymmena. Där trycka reservanterna starkt på, att deras linje skulle bli den billigare. Herr Pauli sade, att det skulle behövas en dubbelt så stor anstalt som den nuvarande, om man hade utbildningen gemensam. Men för det första kan man inte inskränka utrymmena vid institutet till hälften, därför att man minskar elevantalet till hälften, och för det andra är det alldeles uppenbart, att om man skall ha en särskild sjukgymnastikkurs vid ett sjukhus, så måste ett visst utrymme där tagas i anspråk för utbildningen. Man kan ej räkna med, att de utrymmen, som äro avsedda för sjukvården, skola kunna disponeras för utbildning av sjukgymnaster.

Jag har, herr talman, den bestämda uppfattningen, att en lösning av frågan i överensstämmelse med reservanternas linje komme att leda till sänkt nivå såväl i fråga om friskgymnasternas som i fråga om sjukgymnasternas utbildning, och därför vill jag hemställa, att kammaren måtte bifalla utskottets förslag.

2. Olof Olsson (Socialdemokraterna, man)

Frågan om gymnastiska centralinstitutet, herr talman, sådan den föreligger här, har annonserats som en omorganisation. Man har låtit förstå, att vi nu borde få ett slut på det osäkerhetstillstånd, som länge nog har rått på detta område och att striden mellan de olika uppfattningarna hädanefter borde kunna avblåsas.

Det är särskilt mellan två huvudmeningar, som den omtalade striden har stått. Den ena uppfattningen har varit den, att utbildningen vid gymnastiska centralinstitutet bör omfatta såväl sjuksom friskgymnastiken. Den har i det stora hela företrätts av praktiserande gymnaster av olika slag. Den andra uppfattningen åter innebär, att utbildningen av sjukgymnaster är en i det väsentligaste medicinsk angelägenhet och att den följaktligen bör omhänderhavas av läkare. Denna uppfattning har företrätts och företrädes av läkare och framför allt av de medicinska myndigheterna.

Såväl departementschefen som utskottets majoritet ha anslutit sig till den förra uppfattningen. Departementschefen tänker sig på den punkt, som vi för närvarande avhandla, en utbildning på två år, gemensam under det första året och sedan under det senare året uppdelad på två skilda linjer. Utskottet för sin del går in för en gemensam utbildning under en tid, som man inte alldeles säkert är på det klara med, hur lång den skall bli, samt anser vidare, att resten av utbildningen bör löpa längs två linjer, alldeles som departementschefen föreslår. Men vad som är intressant i utskottets framställning är inte så mycket detta, att det har anslutit sig — i varje fall i viss mån — till departementschefen, utan det är den motivering, som det åberopar.

Denna motivering går fram så att säga på två led, utav vilka det ena ledet går framlänges och det andra baklänges. Jag förmodar, att kammarens ledamöter inte på något särskilt ingående sätt ha studerat statsutskottets utlåtande, och jag skall därför be att få bli ciceron en stund.

Utskottet börjar med att säga, att om man ser saken rent praktiskt, så finnes det goda skäl för att låta den statliga sjukgymnastikutbildningen omhänderhavas av samma anstalt, som har hand om utbildningen av friskgymnaster. Det är nämligen ostridigt, säger utskottet, att till en viss grad samundervisning här med fördel kan äga rum. Sedan fortsätter utskottet sin bevisföring med att säga, att även den hittillsvarande traditionen på området talar för, att sjukgymnastikutbildningen bör stanna kvar inom centralinstitutets verksamhetskrets, och det slutar med ett understrykande av, att man inte får bagatellisera betydelsen av den erfarenhet i ämnet, som under alla dessa år samlats vid centralinstitutet. Slutsatsen av denna bevisföring blir så den, att övervägande skäl tala för, att utbildningen av sjukgymnaster även hädanefter bör få tillhöra centralinstitutets uppgifter.

Men när utskottet har hunnit så långt, gör utskottet först halt och sedan helt om, och så börjar återtåget. Det börjar på det viset, att man säger, att det är synnerligen angeläget, att i denna utbildning inte får ingå några moment, som kunna betecknas såsom obehövliga med tanke på vederbörandes blivande levnadskall, och eftersom nu den här utbildningen i hög grad har medicinsk karaktär, så bör den ställas under överinseende av sakkunnig handledning och intimt anknytas till klinisk och poliklinisk tjänstgöring vid en större sjukvårdsanstalt. I detta avseende har departementschefen visserligen tagit ett steg i rätt riktning, men han har tyvärr skattat alldeles för mycket åt samhörigheten på bekostnad av vad vardera linjen behöver för sin speciella yrkesutbildning. Av detta lilla återtåg i bevisföreningen blir sedan slutsatsen den, att »gemensamheten i undervisningen kan avsevärt inskränkas — måhända

blott till en termin under första året». Det vill med andra ord säga, att alla de praktiska synpunkterna, hela den gamla traditionen såväl som den gamla erfarenheten vid institutet — allt det där, det räcker inte längre än till en gemensam utbildning, som »måhända» blott behöver äga rum under en termin under det första året.

Det är väl klart för var och en, som läst sig in i det här ärendet, att om utgångspunkten hade varit den riktiga, så hade utskottet inte behövt göra denna rätt kuriösa helomvändning. Hade det verkligen varit så, att det hade funnits de starka skäl, som man först försäkrar, så skulle de skälen naturligtvis ha räckt längre än till en tvivelaktig enterminsgemensamhetsundervisning. I det fallet är herr Rosén, förefaller det mig, den, som har den rimligaste ståndpunkten. Han står kvar i första ledet och rör sig fortfarande framlänges. Vad utskottet vill och vad som blir resultatet av dess ståndpunkt, det är, att man låter G. C. I. endast skenbart ha hand om undervisningen i sjukgymnastik. Man skapar en institution, som visserligen har lärjungar, men vilka endast till halvparten äro institutionens lärjungar. Den får en stor lärarstab, som i stor utsträckning är obehövlig, ty det är ju på det viset, att sedan man har begränsat undervisningen vid G. C. I. till det rätta måttet — »måhända» till en termin — sedan lämna ju sjukgymnasterna gymnastiska centralinstitutet och vandra sin väg till serafimerns sjukvårdsimrättningar. Där få de sina egna lärare, och de ha sedermera i fortsättningen inte det minsta med gymnastiska centralinstitutet att göra. Jo, på en punkt, och det är, när det gäller att bygga för gymnastiska centralinstitutet. Det kan då

hända, att man måste bygga för 60 elever, när man i grund och botten — realiter — inte skulle behöva bygga för mer än 30.

I allt det myckna virrvarret av åskådningar och meningar och förmodanden och vad som kommit fram i diskussionen här om romantiken och empirien, traditionen, prestigen, monopolet och de där andarna, som enligt herr Åkerberg sväva över vattnet, finnes det två fasta punkter. Den ena av dessa fasta punkter är den, att alla de kommittéer, som ha suttit, och överhuvud taget alla de, som ha sysselsatt sig med detta spörsmål, ha varit eniga om en sak, nämligen den, att gymnastiska centralinstitutets huvuduppgift är att utbilda gymnastiklärare för våra olika anstalter. Och den andra fasta punkten i virrvarret är den, att alla medicinska myndigheter, som ha yttrat sig i denna sak, ha varit fullt eniga om den ståndpunkten, att gymnastiska centralinstitutet inte är lämpat att utbilda sjukgymnaster.

Det förefaller mig, som om den naturliga slutsatsen ur dessa båda premisser inte skulle vara så synnerligen svår att draga. Vi behöva gymnastiklärare för olika läroanstalter. Dessa gymnastiklärare ha sin speciella uppgift; de måste också på grund därav ha sin speciella utbildning, och denna måste ske under utbildningsförhållanden, som ge de bästa resultat, som man kan nå. Vi behöva vidare sjukgymnaster. Dessa ha i samhället sin alldeles särskilda uppgift; de måste för den uppgiften ha sin särskilda utbildning, och för denna måste de 1 sin tur ha utbildningsförhållanden, som ge i det fallet det bästa möjliga, som man kan tänka sig. Om det nu vore på det viset, att dessa båda utbildningslinjer i det väsentliga eller i väsentliga delar sammanfölle, då vore det naturligtvis riktigt och rättast, att man hade samundervisning. Men det visar sig, att det inte är på det viset. Utskottets majoritet, som efter mitt sätt att se har stirrat sig blind på det förhållandet, att samundervisning en gång förr i större utsträckning har ägt rum och som dessutom har ansträngt sig till det yttersta för att finna nödvändigheten av så mycken samundervisning som möjligt, har inte kunnat få fram någonting annat än detta, att måhända kan samundervisning behövas under en termin. Detta »måhända» innesluter åtskilliga frågetecken. Man är långt ifrån på

det klara med, huruvida det behöves en termin. Personligen tror jag, att det behöves mycket mindre än denna termin. Men hur man nu än tänker sig det, så kan man ju inte se bort från detta, att efter denna lilla samundervisning, den må sträcka sig över ett par månader eller en termin, skickar man bort sjukgymnasterna, och sjukgymnaster och friskgymnaster komma sedermera att leva i fullkomligt skilda världar; friskgymnasterna gå till sina gymnastiksalar och idrottsplatser, och sjukgymnasterna gå till sina kliniker och polikliniker utan att någonsin vidare få någon som helst beröring med varandra. Jag tycker, att det är helt naturligt, att det under sådana omständigheter inte är till någondera gruppens nytta att tvinga dem samman på någon punkt. Det är nyttigare, om de olika grupperna redan från första början kunna inrikta sig på den utbildning, som skall bli deras, så att allt vad som meddelas dem tjänar just denna utbildning.

Om vi följa statsutskottets förslag i dag så lösa vi inte frågan. Den kommer igen förr eller

senare och kräver att få de svårigheter avhjälpta, som vi nu lägga i dess väg, och det är på grund därav, herr talman, som jag för min del ber att få yrka bifall till den av herrar Lindblad m. fl. vid betänkandet fogade reservationen.

3. Sam Stadener (Liberala samlingspartiet, man)

Herr talman! Någon yttrade för en stund sedan, att det vid statsutskottets behandling av detta ärende hade rått en stor ovisshet i sinnena och att det åtminstone till en början varit svårt att åstadkomma ett beslut, bakom vilket en tydlig majoritet befann sig. Jag har intrycket, att även i första kammaren i dag råder ovisshet om, vilkendera av de föreslagna vägarna kan vara den lämpligaste för icke endast de yrkesmän, vilkas öde vi närmast avhandla, utan också för vårt land i gemen och isynnerhet dess folkhälsa. Själv tillmäter jag mig givetvis ej större sakkunskap på detta område, men omständigheterna under min levnad ha fört mig i så nära beröring med utövare av såväl friskgymnastik som sjukgymnastik, att jag sedan åtskilliga år tillbaka, ja sedan ett par decennier försökt, så gott det varit möjligt, följa utvecklingen och tilldragelserna på detta område.

Jag har därvid inte skattat — såsom en ärad talare trodde, att Kungl. Maj:t gjort i propositionen — alltför mycket åt romantiken. Den ärade talaren, till vars framställning jag lyssnade med stort intresse, berättade åtskilligt om Ling. Ling var, sade han, ej bara skald utan också en empiriskt orienterad ande, som stod på verklighetens mark. Han var skald, och han var realist. Vad nu beträffar den ärade talaren, så syntes det mig, att han med hänsyn till ordens höga flykt i hans eget anförande hade något mera av skalden Ling än av realisten Ling. Jag är oförmögen att i samma omfattning som han harangera Lings skugga. Jag får hålla mig till vad jag nyss antydde: de iakttagelser och upplevelser och bokliga studier, som jag kan ha gjort i ämnet.

Min ståndpunkt är påverkad av erfarenheter, som jag gjorde som svensk präst i utlandet. Jag tillbragte tiden huvudsakligen i ett större kulturcentrum, men jag hade tillfälle att knyta bekantskaper även på andra platser och i andra länder. Jag märkte icke då, och jag har ej förnummit sedermera, att det finnes verklighet bakom ett påstående, som gjordes för ett ögonblick sedan, att den svenska gymnastiken i sin omfattning av både friskoch sjukgymnastik, skulle ha gått tillbaka, skulle ha förlorat sin reputation ute i världen eller, med andra ord, skulle ha blivit antikverad. Det kan vara möjligt, att någonstädes i utlandet de svenska gymnastiska instituten ha minskats till antalet. Därmed har ingen skada skett, ty man har i stället åstadkommit en så mycket starkare koncentration, och en del utväxter av mindre nyttig art på den svenska gymnastikens område ha blivit bortopererade. I verkligheten, mina herrar, förhåller det sig så, att den svenska gymnastiken i utlan-

det har lyckats vinna uti det långa loppet. Den har efter decenniers tävlan och ett i stort sett troget arbete på sitt fält lyckats vinna den allmänna aktning, som har förmått vederbörande länders styrelser — icke överallt, men på många ställen — att taga initiativ till ett införande i dessa länders egna organisationer av den svenska sjukoch friskgymnastikens principer. I samma mån har naturligtvis en viss avkoppling av den genom svenskar bedrivna

gymnastiken i utlandet ägt rum.

Jag skall tillåta mig anföra något litet om detta för att korrigera felaktiga uppgifter, som lämnats. Vad beträffar Tyskland, som ligger oss närmast, så är dess förnämsta anstalt för fysisk fostran, en anstalt av väldiga mått, förlagd till Spandau: Deutsche Hochschule fär Leibesäbungen. Den upptager sjukdomslära, anatomi, fysiologi, rörelselära och sjukgymnastik och visar sig vara, om icke ett avtryck av svensk gymnastik, så dock en institution, som har lärt vid den svenska gymnastikens fötter. Vad beträffar Sachsen, så har man där en statsinstitution närmast för sjukgymnaster, som har hämtat sitt förnämsta mönster från vårt svenska gymnastiska centralinstitut. I Minchen har man lagt grunden till en liknande anstalt under klart och tydligt betonande, att det är på det svenska gymnastiksystemets grund, som utbildning skall ske. För att gå något längre bort så upprättades i Turkiet för fyra eller fem år sedan också ett statsinstitut av landets nuvarande styresman för utbildning av lärare i svensk gymnastik och övrig fysisk fostran: det är organiserat av svenskar och svensk sjukgymnastik ingår till betydande omfång i utbildningen. Detsamma skulle jag kunna förtälja från Rumänien och sedan många år tillbaka från Portugal. Det senaste är att Grekland genomfört en lag, som gör den svenska gymnastiken obligatorisk, och som givit en storstilad gestaltning åt den fysiska fostran efter svenska mönster. Det kan ju intressera den ärade talare, som i fråga om utbildningstidens längd uttryckte mer än han själv trodde av min egen personliga tankegång, att man i detta land har Just en treårig studietid. För övrigt har grekiska staten i år skickat sex stipendiater till gymnastiska centralinstitutet för att där studera och bereda sig till sin blivande uppgift i det statliga institutet i sitt fädernesland.

Jag skall ej längre upptaga kammarens tid med denna sida av saken. Den svenska gymnastiken i sin gestaltning av kombinerad friskoch sjukgymnastik är ingen faktor, som har spelat ut sin roll i världen, utan tvärtom en, som tillerkännes priset vid en tävlan, som har försiggått sedan generationer. Jag är liksom herr Björck glad över, att centralinstitutets organisationsfråga har blivit lyftad upp ur beredningarnas oroliga såll och nu proponerad till beslut inför riksdagen. Men jag kan ej neka till, att jag hade blivit ännu gladare om den ärade talaren och reservanterna ej sedan gjort allt vad de kunnat för att förpassa frågan tillbaka igen till utredningarnas sakta malande kvarnar. Varken de eller någon annan kan förutsäga, när frågan i så fall sedan kan beräknas komma tillbaka på riksdagens bord.

Mina herrar! Tvisten, som det gäller och som i regel kallas frågan angående förening mellan eller åtskiljande av sjukgymnasternas och friskgymnasternas utbildning denna tvist återgår egentligen till en klyvning, som man på visst håll strävar efter att genomföra i den svenska sjukgymnastiken. Sjukgymnasten har, såsom det påpekas i synnerhet från reservanternas sida, en terapeutiskt uppgift, men denna fördelar sig på tvenne olika grupper eller stamledningar. Den ena av dem kallar man rörelseterapien. Det är den läkeverksamhet, den sundhetsgymnastik, som arbetar med rörelsemetoden. Den andra kallar man fysikalisk terapi, och därmed menar man behandling med värme av olika slag: elektroterapi eller liknande. Var och en förstår, att denna sista eller den fysikaliska terapien står betydligt närmare

sjukhusförhållandena än

rörelseterapien. Rörelseterapien är av naturliga och lätt insedda grunder en följeslagare till friskgymnastiken.

Dessa former av hälsovård äro ej nya imom det gymnastiska centralinstitutet. Det kan ju vara intressant — och det kan vara lämpligt att rätta ett och annat misstag, som i detta hänseende blivit gjort — att veta, att redan på 60- talet övades dessa olika former av terapi på gymnastiska centralinstitutet, men först under senare tid, eller man kan kanske rent av våga säga under det sista årtiondet, har den fysikaliska terapien och dess nytta och gagn blivit mera observerad inom läkarekåren än till förene. Det finnes belägg för detta mitt påstående från läkarna själva. Sålunda kan man läsa i 1929 års sakkunnigutlåtande, som är författat av professorerna Hedrén och Haglund: »Läkarna ha först sent intresserat sig för dessa utanför den egentliga sjukvården bedrivna behandlingsmetoder.> Och man läser i fortsättningen till samma utlåtande: »Dessa läkare, med huvudintresset riktat åt andra sjukvårdsuppgifter, ha ofta litet intresse och därtill oftast mycket liten kompetens på detta område av praktisk läkekonst.» Herrarna torde observera, att det är citat och att det alltså icke är jag, som uttalat detta om läkarna, utan det är läkarna själva, som fällt omdömet. Erkännandet att man först på sista tiden inom läkarkretsar begynt värdesätta sjukgymnastiken får sin förklaring, om det är riktigt, som man sagt mig, att utbildningen i sjukgymnastik icke är obligatorisk för våra läkares utbildning utan en frivillig tillsats i sagda utbildning. Den läkare, som så vill, kan genomgå en frivillig kurs, som dock är begränsad till 20 timmar. Var och en inser, hur mycket kompetens, erfarenhet och omdömesförmåga, som uppkommer på detta sätt.

Herr förste vice talmannen yttrade, att för honom fanns det två fasta punkter i hela denna oroliga diskussion. Den ena punkten var den, att gymnastiska centralinstitutets huvuduppgift är att utbilda gymnastiklärare. Den andra punkten var läkarnas stora enhällighet om gymnastiska centralinstitutets olämplighet för sjukgymnastisk utbildning. Jag föreslår, att herr förste vice talmannen strax reducerar detta tvåtal av fasta punkter till en genom att stryka den sista. Läkarna äro nämligen icke enhälliga i det anförda omdömet. Det kan vara nog att erinra sig, att i 1924 års sakkunnigkommission, som fasthöll att utbildningen i sjukgymnastik skall förbliva på centralinstitutet, satt — utom ordföranden, vars namn man också kan i detta sammanhang erinra sig, dåvarande generalkrigskommissarien Rydén — såsom sakkunnig på läkarområdet den kände överläkaren på Sabbatsberg doktor Hybbinette. I 1927 års sakkunnigkommitté satt såsom medicinsk sakkunnig professorn vid Karolinska institutet Göran Liljestrand. När 1927 års betänkande skulle behandlas och utlåtande skulle avgivas däröver, satt i direktionen för gymnastiska centralinstitutet en ordförande, som ställde sig på 1927 års sakkunnigas sida och alltså ville ha kvar sjukgymnastiken på centralinstitutet, och denne ordförande var den dåvarande rektorn vid Karolinska institutet professor J. E. Johansson. Tilllåt mig, när jag nu håller på att citera vad folk sagt om denna sak, att också anföra en auktoritet, som visserligen ej är läkare, men som har till uppgift att närmast presentera inför Kungl. Maj:t vad läkarna och de medicinska fakulteterna yttrat och som

sålunda har att i första hand sätta sig in i de medicinska utlåtandena, nämligen universitetskanslern! Han avstyrkte 1929 års sakkunnigutlåtande, som gick ut på att taga bort sjukgymnastiken från gymnastiska centralinstitutet. Sedan han läst de medicinska utlåtandena, yttrade han nämligen till Kungl. Maj:t, att han kände mycket stor tvekan om lämpligheten att helt skilja sjukgymnastutbildningen från utbildningen av gymnastiklärare, och han slutade med att säga, att han ifrågasatte, huruvida icke utbildningen av sjukgymnaster alltjämt borde fortgå vid gymnastiska centralinstitutet. Och vidare, mina herrar, mot de avstyrkande utlåtanden, som kom-

mit från medicinskt håll, även om medicinarna icke varit enhälliga, står så gott som endräktig med högst få undantag den yrkesutövande delen av vårt folk på detta område, d. v. s. friskgymnasterna och sjukgymnasterna, både de som praktisera hemma hos oss och de som arbeta i utlandet.

Reservanterna hava åberopat sig i första hand, som naturligt är, på vissa läkarutlåtanden. En talare har för ett ögonblick sedan på ett enligt min mening framgångsrikt och ovederläggligt sätt uppvisat, att reservanterna stå i ett slaviskt beroende av sina auktoriteter. Man skulle knappast ha trott dem om denna totala underkastelse. Ty även sina auktoriteter bör man lyssna till med vaken kritik. Jag skall för att belysa saken citera vad centralstyrelsen för Sveriges läkarförbund yttrade för icke så länge sedan i anledning av 1929 års sakkunnigutlåtande, som ville skilja sjukgymnastiken från centralinstitutet. Centralstyrelsen för läkarförbundet yttrade: »Sjukgymnastens verksamhet skall vara att enligt läkares anvisning biträda med» — märk väl — »en viss art av terapi» — det var den jag talade om nyss — »ett arbete som vore vitt skilt från verksamheten för vårt folks fysiska fostran.» Det är uppenbart en felaktig definition på sjukgymnastiken. Det behöver man icke länge diskutera om. Aven sakkunniga av år 1929 ha själva framhållit sjukgymnastikens fortsatta utveckling i vårt land såsom en funktion, som kan förbehållas åt sjuksköterskekåren. 1929 års sakkunniga säga — Jag citerar — »Att i detta livliga framåtgående sjukgymnastiken i egentlig mening dock spelar en vida mindre roll än massagen och den fysikaliska terapien.» Alltså, tyngdpunkten i sjukgymnastiken förlägges till massage och den terapi, jag nyss sökte beskriva, och dessa göromål överflyttas på en **kvinnlig**[1] kår, närmast likställd med eller kanske stående något högre men i alla fall närgränsande till **sjuksköterskorna**[3]. Det säges i samband därmed, att å de medicinska och kirurgiska avdelningarna såväl som på de speciella sjukvårdsavdelningarna och alldeles särskilt de ortopediska och neurologiska förefinnes ett stort och dagligt behov av dessa terapiformer. Med andra ord, för 1929 års sakkunniga synes sjukgymnastiken väsentligen endast vara en art av behandling, anförtrodd åt en **kvinnlig**[1] kår på sjukhusen. Det säges också uttryckligen, att man åsyftar att skaffa sig en sådan kår, och detta är orsaken varför man vill avskilja sjukgymnastutbildningen från centralinstitutet.

Nu har jag verkligen den uppfattningen, att i denna strävan från läkarnas sida finnes något som är berättigat, ty det bör framkalla enbart glädje, att man på sjukhusen vill begagna sig av här omtalade terapeutiska former, men Jag kan icke inse, varför ej lämpliga

behandlingsmetoder kunna åstadkommas på sjukhusen, utan att man vidtager så våldsamma åtgärder som att fullständigt avstänga alla män i vårt land från sjukgymnastisk utbildning. 1929 års förslag gick nämligen ut på att skaffa landet den kår av väl utbildade **kvinnliga**[1] sjukgymnaster, som kräves för våra sjukhus. I detta syfte har man föreslagit enbart **kvinnliga**[1] elever såsom hädanefter berättigade att utbildas till sjukgymnaster. Från detta ha visserligen reservanterna tagit avstånd, men det är dock 1929 års sakkunnigförslag. Vederbörande, 1929 års sakkunniga, råkade emellertid i bekymmer. De säga en ganska munter bit i deras utlåtande — att »vissa behandlingar av stora och tunga män kunna, om ock undantagsvis, vara så arbetsamma, att **kvinnor**[1] ej alltid rå med dem». Men de trösta sig strax därpå med följande ord: »Mycket av den muskelmassage och enklare rörelsebehandling, som ju ofta kan vara särdeles behövlig även för stora och tunga män, meddelas numera i mycket stor utsträckning i samband med badbehandling av manlig badbetjäning.» =D. v. s. med andra ord, att det var nära, att läkarna hade plockat ut ur sjukgymnastutbildningen sådana moment, varav man är mest betjänt på sjukhusen, i synnerhet på vissa avdelningar, och sedan överlämnat det övriga till den manliga badbetjäningen.

Det är mig en glädje att konstatera, att allvarlig opposition inom läkarkretsar väckts mot detta. Professorerna Bårány och Backman ha i kraftiga ord opponerat sig. Vid medicinska fakultetens behandling av frågan i Uppsala, påpekade de, att det var de manliga sjukgymnasterna, som fört den svenska gymnastiken framåt, och att om de **kvinnliga**[1] gymnasterna förtjänade all heder och aktning, det dock hade fallit på de manligas lott att göra propaganda och bereda marken för den svenska sjukgymnastikens framgångar. Dessa professorer säga, att de manliga sjukgymnasterna ha visat sig äga företräde både med hänsyn till den fysiska prestationen och själva behandlingen liksom ock till det kritiska omdömet, när det gäller behandlingen.

Jag skulle även vilja här säga något om kostnaderna. Herr Pauli förebrådde, på ett försynt och angenämt sätt, utskottet och bakom utskottet Kungl. Maj:t, att det icke hade uppgivit, vad centralinstitutets sjukvårdsutbildning skulle kosta. Ifall man skulle ha kvar sjukgymnastiken på centralinstitutet, skulle ju en stor del av utbildningen försiggå genom praktiska övningar på sjukhusen. När herr Pauli sade, att man icke hade fått veta vad detta skulle kosta, så medger jag, att man kanske borde ha gjort ett försök att angiva detta i penningar, men det förefaller mig mycket mer anmärkningsvärt, att ej herr Pauli tillsammans med sin medmotionär upplyst om vad det skulle kosta med en ny statlig sjukgymnastutbildning. En sådan isolerad utbildning är lättare att överskåda. Den är icke sammanfogad med friskgymnastiken utan den kan bedömas och tagas för sig själv.

Herr talman! Det finnes nog andra synpunkter att taga i övervägande i denna viktiga fråga. Men det viktigaste för mig är att jag icke har såsom herr förste vice talmannen två fasta punkter i frågan. Jag har endast en fast punkt, och det är den, att ingendera av sjukgymnastiken och friskgymnastiken blir komplett vad den skall vara utan att ha den andra i tankarna och inom räckhåll. Med andra ord, våra gymnastiklärare, för att taga ett praktiskt

exempel, som utbildas i friskgymnastik på centralinstitutet, kunna aldrig fylla vad läroverksstadgan och undervisningsplanen redan pålägga dem, om de ej ha tillfälle till utbildning i sjukgymnastik. Läroverkslärarna i gymnastik ha nämligen uppgiften att meddela hållningsrättande rörelser och liknande till svagare och klenare barn, för vilka den vanliga friskgymnastiken ej kan användas. För att kunna detta måste de ha insikt och erfarenhet i sjukgymnastiken, och framför allt måste de ha vad man kallar rörelsekänsla, d. v. s. en omedveten och omedelbar förnimmelse av, hur långt man kan driva en viss rörelse, för att man ej skall överskrida gränsen för det nyttiga med just denna rörelse. Det är så viktigt, att jag vill i min egenskap av skolans målsman lägga kammaren på hjärtat att icke beröva utbildningen av läroverkens gymnastiklärare den omedelbara tillgång till utbildning i sjukgymnastik, som ligger i båda dessa utbildningsformers sammanhållande på samma institut.

Utan tvivel kan man göra samma påstående, då det gäller sjukgymnasterna. Reservanterna framhålla med stor éclat, att siukgymnasterna skola sköta sjuka människor, men, mina herrar, man kan ej sköta sjuka utan att veta, hur friska människor skola skötas. Man kan icke sköta sjuka organ, om man ej vet, huru friska organ fungera. Man kan ej bli en framstående sjukgymnast utan att ha omedelbar kontakt med och verkligt inlevande i de rörelsemoment, som konstituera friskgymnastiken.

Herr talman! Jag talar med varmaste övertygelse för bibehållandet av dessa två utbildningsformer i samma institut.

4. Petrus Gränebo (Bondeförbundet, man)

Jag anser, att de fasta punkterna i denna fråga varom man talar ha under den tjuguåriga utredning, som densamma varit föremål för, visat sig vara ganska flytande. Den splittring 1 åsikterna,

som varit rådande under denna frågas förberedande behandling, föreligger Ju till och med i dag här vid kamrarnas ståndpunktstagande till frågan.

Jag skall nu icke efter herr statsrådets anförande gå in så djupt i denna fråga — herr statsrådet har ju allsidigt belyst densamma — utan jag skall endast, eftersom jag deltagit i behandlingen av denna fråga i utskottet och dessutom är ganska intresserad av att den nu får en lösning, uttala, att jag anser, att det ej vore lyckligt att nu åtskilja helt och hållet sjukgymnastoch friskgymnastutbildaingen. Utskottet har här sökt gå en gyllne medelväg och har i det avseendet gått något längre än vad Kungl. Maj:t i propositionen föreslagit i fråga om uppdelning av utbildningen. Man har mera, kan jag säga, följt den i andra kammaren väckta motionen om att i något större utsträckning, än Kungl. Maj:t föreslagit, tillgodose sjukgymnastutbildningen genom att på ett tidigare stadium specialisera denna utbildning och skilja den från friskgymnastutbildningen.

Att här exakt fastslå, att det behöves så många timmar för sjukgymnastutbildningen och så

många för friskgymnastutbildningen, att den utbildningen skall ordnas på det sättet och den utbildningen på det sättet, torde icke vara lätt för en lekman, i synnerhet som de sakkunniga, vetenskapsmännen, ej kunnat enas. Nu är det emellertid så att vetenskapsmännen äro sällan eniga, och en person sade mig för en stund sedan, att vore läkarna eniga, vore det betänkligt, då vore det farligt att tillstyrka saken. Det kanske ligger något i det. Därför bör man kanske ej ställa kravet på enighet från den sidan alltför högt. .

Jag anser emellertid att den ståndpunkt, utskottet nu intagit, på ett någorlunda tillfredsställande sätt tillgodoser båda grenarna av gymnastutbildningen. Man bibehåller ändå Lings gamla skapelse. Det är icke för att värna traditionen, ty det behöva vi ej, som vi anslutit oss till denna ståndpunkt. Jag skall senare svara herr Björck, som gjorde gällande, att de borgerliga i detta avseende äro mera traditionsbundna, än vad socialdemokraterna äro, och att vi därför kanske hade skilt oss från dessa.

Det är emellertid den andra punkten, varom meningsskiljaktighet råder, som jag något närmare vill beröra. Jag skulle snarast tro, att i den första punkten ha väl de flesta bildat sig en åsikt. Men i fråga om den andra stridspunkten, nämligen inträdesfordringarna, vill jag påpeka för herrarna, att det är en viss skillnad mellan utskottets förslag och reservationen. Reservationen avser ju avskiljande av friskgymnastikutbildningen från sjukgymnastutbildningen. Friskgymnastutbildningen har ju i huvudsak till syfte att utbilda gymnaster, som skola tillgodose skolungdomens fysiska fostran, utbilda gymnastiklärare och militärgymnaster, medan sjukgymnastiken huvudsakligen avser att tillgodose det mera medicinska behovet. Den förra kursen består ju till största delen av manliga elever, medan den senare i huvudsak utgöres av **kvinnor**[1].

För att bli sjukgymnast bör väl icke fordras studentexamen. Det skulle väl vara att ställa ett alltför högt krav, medan för gymnastikdirektör och gymnastiklärare vid skolväsendet studentexamen torde behövas. Om man därför nu här skulle bifalla utskottets förslag i övrigt men bifalla reservationen beträffande inträdesfordringarna, har man gjort en spärr som omöjliggjort för **flickor**[2], som icke tagit studenten, att bli sjukgymnaster, och det torde väl ändå icke kammaren vilja vara med på.

Här skulle jag gent emot herr Björck vilja säga, att det förvånar mig att herr Björck, som efter genomförandet av 1927 års skolreform, velat befrämja möjligheterna för inträdet vid våra olika utbildningsanstalter och att därför ej allt för höga inträdesfordringar borde sättas, nu anser att studentexamen bör fördras för utbildning till sjukgymnaster. Jag vill emellertid ytterligare

fästa uppmärksamheten på, att det är skillnad, om man här betäffande inträdesfordringarna bifaller reservationen eller om man biträder utskottets hemställan.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

5. Alfred Petren (Socialdemokraterna, man)

Jag hade icke tänkt yttra mig i denna debatt, då jag icke haft tillfälle att deltaga i ärendets behandling i utskottet, men i anledning av herr Åkerbergs anförande anser jag mig ej kunna underlåta att säga några ord. Herr Åkerberg påstod nämligen, att alla läkare, som förstå denna fråga, hölle på en fortsatt sammankoppling av utbildningen för gymnastiklärarna och utbildningen för sjukgymnasterna.

Detta hans påstående innebär sålunda en inkompetensförklaring i fråga om bedömandet av denna fråga hos såväl den för vårt sjukvårdsväsen ansvariga styrelsen i vårt land som hos dem, vilka ha att sköta läkarutbildningen, liksom även hos dem, som läkarna själva ha valt till sina förtroendemän. Ty det förhåller sig i själva verket så, att när 1927 års sakkunnigförslag kom angående bibehållandet av detta samband mellan gymnastiklärareoch sjukgymnastutbildningen, uttalade sig häremot medicinalstyrelsen, alla de tre medicinska fakulteterna, centralstyrelsen för Sveriges läkarförbund och styrelsen för Sveriges yngre läkares förening.

Nu är det ju alldeles riktigt, som herr statsrådet nämnde, att 1929 års sakkunniga, som förordade skilsmässa mellan gymnastikläraroch sjukgymnastutbildningen, på en punkt gått för långt, så att det icke där rått allmän enighet bland läkarna. Jag syftar på deras förslag, att det endast skulle vara **kvinnor**[1], som kunde få utbildas till sjukgymnaster. På den punkten är det visst icke en enig uppfattning bland läkarna, och även i övrigt torde det, såsom herr statsrådet anmärkte, finnas enstaka läkare, som icke ha något emot en fortsatt sammankoppling av gymnastiklärareoch sjukgymnastutbildningen. Dessa torde dock utgöra ett fåtal. I stort sett torde läkaropinionen tämligen allmänt stå på 1929 års sakkunnigas sida.

Detta har också sin förklaring däri, att en sjukgymnasts uppgift numera är en helt annan och vidare än förr, i all synnerhet gäller detta för de sjukgymnaster, som ha tjänstgöring på sjukhusen. Och det må 1 detta sammanhang framhållas, att det utan tvivel kommer att efter hand bli ett vida större behov av sjukgymnaster på sjukhusen. Ursprungligen hade sjukgymnasterna endast att utföra sjukgymnastik, men så kom inom kort även massage, och sedan är det efter hand en hel del mekaniska och fysikaliska terapiformer, såsom värmeterapi, elektroterapi, ljusterapi etc., som också börjat utövas av dessa yrkesmän. Det är under sådana förhållanden alldeles klart, att det är nödvändigt, att utbildningen av sjukgymnaster bör närmare än hittills skett anknytas till sjukvårdsarbetet. Det är den stora bristen i den nuvarande sjukgymnastutbildningen, att detta icke sker tillräckligt.

Nu erkände visserligen herr statsrådet, att så bör ske, men i propositionen är detta krav alldeles för litet tillgodosett. I det fallet får jag säga, att det förslag, som statsutskottet framlagt, innebär en högst väsentlig förbättring.

Herr statsrådet nämnde något om, att det tycks råda stor ovisshet i första kammaren, hur kammaren vill ha denna fråga ordnad, men på en punkt tycks 1 alla fall med några få

undantag en tämligen enig uppfattning råda, nämligen därom, att det förslag, som Kungl. Maj:t framlagt, ej är tillfredsställande, och det är, som sagt, däri att kravet på sjukgymnastutbildningens anknytning till sjukvården icke blivit tillräckligt tillgodosett. I detta fall har emellertid, som jag nämnde, utskottet gjort en betydande förbättring i förslaget, ty utskottet har ju uttalat såsom önskvärt, att ett samarbete på lämpligt sätt borde ordnas med karolinska institutet i fråga om såväl den teoretiska som den prak-

tiska utbildningen av sjukgymnasterna och det har uttalat sig emot poliklinik för sjukgymnastikbehandling å ett fristående gymnastikinstitut. Alltså har utskottet strukit under nödvändigheten av, att det blir ett tillräckligt samarbete med en sjukvårdsinrättning, där de blivande sjukgymnasterna kunna erhålla en fullgod praktisk utbildning under läkares tillsyn och kontroll. Skillnaden mellan utskottet och reservanterna är ju den, att utskottet i motsats till reservanterna inte velat helt släppa den gemensamma undervisningen, ehuru utskottet föreslår tiden för denna undervisning reducerad till en termin i stället för, såsom Kungl. Maj:t föreslagit, ett år.

Jag skall inte ingå på något bemötande av vad herr statsrådet yttrade på den punkten, då jag ser att herr förste vice talmannen, som deltagit i ärendets behandling i utskottet, har begärt ordet efter mig, men jag vill dock tillägga, att nog tror jag, att man skall komma att finna, att det, när det inte gäller längre utbildningstid än två år, skall visa sig vara praktiskt, att dessa två olika utbildningar planläggas var för sig ifrån början. Den synpunkten, att man även vid gymnastiklärareuntbildningen bör ha kontakt med sjukvården, blir ju uppfylld, ifall utskottets förslag, att institutet förlägges till karolinska sjukhuset, bifalles.

Till sist vill jag endast, med anledning av vad herr statsrådet yttrade mot herr Pauli, påpeka, att då herr statsrådet talar om, att det är så många statsanstalter för utbildning av sjukgymnaster upprättade i utlandet, så talar väl detta närmast för, att de ifrån Sverige utexaminerade sjukgymnasterna nu hålla på att bli överflödiga i utlandet.

Jag får alltså, herr talman, som min uppfattning uttala, att min och herr Paulis motion i denna kammare och herr Lindskogs motion i andra kammaren synas ha gjort mycket stort gagn, då i alla fall utskottet kommit så nära våra synpunkter, som skett.

Jag ber likväl, herr talman, att på de skäl, som jag här anfört, få yrka bifall till reservanternas förslag.

6. Olof Olsson (Socialdemokraterna, man)

Jag skall först, herr talman, säga ett par ord om den fasta punkten. Jag trodde så säkert, att jag hade två fasta punkter att hålla mig till, men herr ecklesiastikministern vill ovillkorligen rycka bort den ena för mig. Det kan han emellertid endast göra på det sättet, att han byter ut ett par ord mot varandra; att han således byter ut orden »medicinska myndigheter» mot »läkare», vilket dock inte alls är detsamma. Det är nämligen så, att i denna proposition, som jag har haft den mödan att närmare studera, lägger man just märke till, hur de medicinska

myndigheterna — i klump nästan — sluta upp kring den uppfattning, som jag nämnde. Man kan också, om man studerar propositionen mycket noga, lägga märke till, hurusom även de tveksamma så småningom sluta upp kring denna samma uppfattning, exempelvis den medicinska fakulteten nere i Lund. Och till dess att jag har blivit överbevisad om, att vad som står här i detta bokhäfte om denna deras uppfattning är felaktigt, så länge håller jag mig till den och har följaktligen fortfarande två fasta punkter i virrvarret.

Sedan vill jag anknyta till ett ord, som herr ecklesiastikministern började sitt anförande med, då han nämligen talade om den osäkerhet, som präglade diskussionen i dag. Denna osäkerhet, som i viss mån också präglar de synpunkter, som kommit fram såväl i utskottets utlåtande som hos reservationerna — ty det vill jag inte fördölja, att visst finns det en viss osäkerhet även där — denna osäkerhet är, säger jag, i hög grad beroende därpå, att vi i den kungl. propositionen ha saknat två väsentliga ting. Vi hade först och främst behövt ha en kartläggning över, hur det förhåller sig med gymnastiklärare och sjukgymnaster och annat därmed närstående i det verkliga livet — hur många

gymnastiklärare och **lärarinnor**[3] vi egentligen ha och hur många sjukgymnaster som äro verksamma och inom vilka verksamhetsområden de fullgöra sitt kall — hur många det finns av det ena eller det andra slaget sjukgymnaster och om det kanske finns typer, som svänga mellan den rena gymnastikläraretypen och den rena sjukgymnasttypen — hur många dessa i så fall äro och hur de ha det i sin gärning. Vi skulle ha kunnat gå fram med en helt annan säkerhet, därest vi hade vetat något om, hur det förhåller sig på dessa olika punkter. Vi hade då haft jämförelsematerial, som kunnat influera på den ställning, som vi borde intaga i dessa ting.

En annan kartläggning, som vi så väl behövt, hade varit en sådan, som visat, vilken utveckling sjukgymnastiken undergått under den senare tiden, en utveckling som väl i hög grad måste ha varit betingad av läkekonstens utveckling och de förändringar, som den genomgått under den sista tiden. Det var för mig rätt intressant att höra departementschefens tal om den fysikaliska terapien, därför att denna ju i allmänhet inte räknas till de ecklesiastika tingen, men det hade varit synnerligen nyttigt, om vi fått en utredning även i det avseendet. När vi nu inte fått sådana utredningar, ha vi måst ty oss till den erfarenhet, som vi själva möjligen kunna ha, och denna erfarenhet är för mitt vidkommande ungefär följande.

De självständiga sjukgymnastiska företagarna, om jag så får kalla dem, är en ras, som är i utdöende, och detta på grund därav, att de ha en alltför liten medicinsk utrustning för att kunna spela den roll, som de böra, om de skola kunna göra mänskligheten någon nytta. Sjukgymnasten däremot, som är läkarens verktyg, utbreder sig allt mer. Det är nämligen på det sättet, att just den fysikaliska terapien — eller låt oss kalla allt detta för medicinsk terapi i stället — övergår mer och mer till att bli precis som medikamenter som skiftas ut i doser, som så mycket annat här i världen. Men det måste vara medicinskt skolat folk, som handhar detta och förstår sig på, i vilken grad man skall taga de där doserna. När herr ecklesiastikministern i

detta sammanhang nämnde gymnastiklärarna vid våra skolor och bad att dessa inte skulle utestängas ifrån den sjukgymnastiska utbildningen, så visade detta, på vilken fel väg man verkligen här är inne. Gymnastiklärarna skola inte sysselsätta sig med sjuka. Gymnastikläraren har visserligen de s. k. svagrotarna, som han har att taga hänsyn till, men det är skolläkarna, som skola sköta om de sjuka vid skolorna, och jag skulle beklaga den dag. då gymnastiklärarna intoge deras plats. Men det finns ju inte något skäl att ytterligare fördjupa sig i denna fråga.

Det föreligger två linjer här, som jag tycker äro mycket klara. Den ena linjen är gymnastiklärarnas linje och den andra är sjukgymnasternas. De båda linjerna korsa inte varandra någonstans, men på en liten punkt beröra de varandra: gymnastiklärarna behöva onekligen veta litet om sjukgymnastik, och sjukgymnasterna behöva också veta något litet om friskgymnastik. Men detta vetande är inte på någondera sidan av den betydelse, att dessa båda grupper, gymnastiklärarna och sjukgymnasterna, för den skull behöva gå arm i arm i undervisningen någon längre tid. Den, som går in för utskottets förslag, går också in för detta armi armgående; den, som ansluter sig till reservanternas förslag, går in för. att båda dessa grupper av samhällsmedborgare, med olika uppgifter och följaktligen också olika utbildningsbehov, skola få sina olika utbildningslinjer redan från början lagda så, att de anpassas efter precis vad de behöva ge och ingenting annat. Det är på grund därav att frågan för mig ligger så klar, som jag inte kan vilja vara med om att röra tillsammans detta till en enda institution, som får skenet av att vara en institution för båda parterna, men i grund och botten bara är en institution för den ena parten.

Jag vill därför, herr talman, fortfarande vidhålla det yrkande jag tidigare glort.

7. Carl Lindhagen (–, man)

Herr talman! Herr Pauli sade, att reservanternas linje var klar och enkel. Ja, nog är det klart, att den är enkel, men att den är för enkel, det har jag klart för mig.

Här har riktats erinringar mot traditionsbundenhet. Jag är så litet allmänbildad, att jag aldrig befunnit mig i Lings skugga, framför allt därför att Jag inte haft tid därtill. Här befinna sig några å andra sidan i läkarnas skugga. Den siste ärade talaren sade ju till och med, att sjukgymnasterna hade till livsuppgift att bli läkarnas verktyg. Det kanske är därför, som de alla lära protestera emot reservanternas uppfattning. De vilja förmodligen icke bli verktyg utan vara självständiga, tänkande och tillräckligt kvalificerade personer själva.

Vidare har man här i diskussionen hyllat också studentexamen. Det är väl beroende på någon slags hypnos, att så skett. Tänk ändå, att man nu skall ytterligare på detta område vilja täppa till möjligheterna för dem, som inte ha tillfälle att taga studentexamen, att kunna utnyttja sina gåvor och förvärva sitt livsuppehälle! Det är verkligen en enkel linje detta med studentexamen, måste jag säga. Min lösen är snarare: ned med studentexamen.

Slutligen har sagts, att det blir billigare att gå på reservanternas linje än att följa Kungl. Maj:ts

förslag. Men det är väl inte någon av herrarna, som tror, att reservanterna själva förstå sig på att förutse den saken, ty det är något, som vi inte veta alls. Har man anledning tro, att det blir billigare med en reform, än om man inte reformerar alls? Det har jag åtminstone i riksdagen knappast upplevat. Och hur kan man tänka sig, att det skall bli det billigaste sättet, att lägga den ena sidan av utbildningen helt och hållet under läkarna? Det finns väl få saker, som äro dyrare än de medicinska sjukhusen och vad därtill hör — det är väl miljonrullning så det förslår! Däremot betraktas undervisning i konsten att förekomma sjukdomar genom individuell hygien som ett ringa ting, förtjänt tillräckligt av några småsmulor. Inga auktoriteter stödja med kraft sådana strävanden. Det påståendet bygger jag på en under långvarig riksdagsverksamhet vunnen erfarenhet.

Nu föreställer jag mig, att kroppens olika delar höra ihop och att således också begreppen frisk och sjuk höra samman. Den som är sjuk vill man göra frisk, och den, som är frisk, bör ej göras sjuk. Dessa verksamhetsgrenar ha väl ingående beröringspunkter med varandra. Den fasta, enande punkten det är människans kropp och ej de här administrativa separata riktlinjerna.

Sjukoch friskgymnastikens yrkesmän äro tillika så att säga folkets Jäkare 1 hälsovård; de kunna, rätt utbildade, i sin mån tillsammans verka som dessa mera enkla, lättfattliga och i praktiken verkande redskap, som folkhälsan behöver. Genom införlivande med den högre läkarvetenskapen blir den ena hälften av en dylik folkinstitution något underordnat, ett »verktyg» skilt från sin rätta miljö. Där uppe blir allting dessutom gärna dyrt och uppgifterna äventyra att förkvävas av ensidiga synpunkter, doktriner, flyktiga läror, som göra sig gällande. Var tids vetenskap är till hälften byggd på läror, utom naturligtvis de rent naturvetenskapliga ämnena.

Är det tidsenligt och lyckosamt att administrera bort ena hälften av det gamla gymnastiska centralinstitutet på detta sätt? Det är icke läkarnas fel, att i en tid, då läkarundervisningen är företrädesvis inriktad på att bota sjuka, de inte tillräckligt hunnit fram till den lika stora ja, ännu större huvuduppgiften att bevara de friska från att bli sjuka? Det lärer vara bara kineserna, som inställt läkarekonsten främst på den senare uppgiften. De ge, påstås det, läkarna arvode endast så länge familjen är frisk, men när familjen

är sjuk, får läkaren inte något läkararvode längre. Den bästa läkekonsten, består 1, att man skall söka bibehålla människorna friska. Det försummas enligt erfarenheten allt för mycket i de medicinska högskolorna. Det finnes dock läkare, som ryckt sig ut ur denna efterblivna ståndpunkt, och de bli ju lyckligtvis allt fler, det är dessa, som nu bekämpa reservanterna, under det att de, som stå kvar och ha makten fortfarande, leva i gamla föreställningar, och hålla på denna tudelning.

Det är sålunda, såvitt jag förstår, för de ifrågavarande två yrkesgrupperna viktigt, att de från början få hålla ihop. Jag har en förnimmelse, att bristen i det nuvarande systemet kanske

snarare är den, att de hålla ihop under för kort tid, så att de inte få lära sig förstå sammanhanget mellan sina verksamhetsgrenar.

En gymnastiklärare t. ex. bör besinna, att han måste taga hänsyn till individernas olika kroppskonstitution, vad de förmå och vad de intressera sig för, så att han inte genom sin gymnastik gör dem sjuka. Så sker emellertid även i skolorna, när man använder samma schema för starka och ömtåliga barn, vilket ej alltid kan vara förutsett av skolläkaren. I militärgymnastiken spåras den bryska uppfattningen, att vederbörande skola tränas och härdas under antagande, att de alla tåla vid det. Det är därför skolutfärder från Stockholm under militära gymnastiklärares ledning på vintrarna med skidor ibland överforcera barn med svagare kroppskonstitution. Det anses nyttigt för dem, att de härda sig, men jag vet exempel på, att de kommit tillbaka förstörda för livstiden. Det vore väl, om ledarna av friskgymnastiken och vad därmed sammanhänger kunde bibringas vetenskapliga begrepp om sjukdomars uppkomst och sjukgymnasterna tillägna sig naturläkedomen såsom också ett hjälpmedel. Ett dylikt samgående tager man bort genom en så förenklad schematisering, som här ifrågasättes.

Jag tycker nästan, att jag ser Pauli skuren i två delar, den ena delen går till Serafimerlasarettet och blir ett verktyg, den andra går till idrotten och lever sitt eget fria liv. Vad skulle Pauli säga, om en så förenklad och klar metod?

Läkarekåren ställer sig ofta på en så hög medicinsk ståndpunkt och ser ned på dessa andra, mera anspråkslösa arbetare i vingården. Vilken förtryckt ställning och hänsynslös behandling ha icke **sjuksköterskorna**[3] ofta varit utsatta för på sjukhusen. Har den studerade vetenskapen kommit att tänka på att ordna så, att dessa **sjuksköterskor**[3] inte skulle bli omänskligt överansträngda? Nej, häri har det brustit mångenstädes betydligt. Vetenskapen saknar understundom den rätta hänsynen till sammanhanget mellan friskhet och sjukdom och om de menigas människovärde. Nu skall man också under vetenskapen lägga sjukgymnasternas utbildning i skuggan av intellektualismens nedblickande på dem, som inte tagit de stora examina.

Jag känner mig tveksam, huruvida det verkligen är en förbättring, när utskottet tagit bort ifrån Kungl. Maj:ts förslag polikliniken. Jag misstänker, att det är en mager riksdagskompromiss, som delvis förstört det kungl. förslaget.

Därför ber jag, herr talman, att i första hand få yrka bifall till Kungl. Maj:ts förslag i likhet med herr Rosén och i andra hand röstar jag för utskottsmajoritetens förslag i avvaktan på bättre tider.